

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

Vamos começar nossa conversa sobre hipertensão arterial sistêmica trazendo uma ótima notícia: acabou de sair a **nova diretriz brasileira de 2025** e, como vocês vão ver, existem algumas mudanças importantes que com certeza vão aparecer nas provas de residência. Então prestem bastante atenção porque vamos destacar essas novidades ao longo de toda nossa explicação.

Antes de mergulharmos no conteúdo, quero que vocês imaginem uma situação bem prática: você está no ambulatório de clínica médica, seja durante a faculdade ou já na residência, e atende um paciente em primeira consulta. Ao fazer o exame físico, você afere a pressão arterial e encontra **174 por 108 mmHg**. Nesse momento, seu preceptor te pergunta: "Podemos fechar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica? Se sim, em qual estágio esse paciente se encontra?". Ao final da nossa aula, você vai conseguir responder essa pergunta com segurança e sem nenhuma dificuldade.

Vamos trabalhar também com uma questão da **UNICAMP 2025** que ilustra perfeitamente os conceitos que precisamos dominar. A questão traz um homem de 73 anos que comparece para consulta de rotina assintomático, com antecedente de diabetes mellitus, negando tabagismo, hipertensão, dislipidemia ou outras comorbidades. Está em uso de metformina e tem IMC de 31. A pressão arterial no consultório foi de 144 por 72 mmHg. Além disso, ele trouxe uma medida ambulatorial da pressão arterial (MAPA) realizada há uma semana, mostrando PA média nas 24 horas de 132 por 73 mmHg, PA na vigília de 133 por 74 mmHg e PA no sono de 131 por 71 mmHg. A questão pede para você identificar qual alternativa está correta: se o paciente tem hipertensão do avental branco, se tem diagnóstico confirmado de HAS, se precisa confirmar com outra medida no consultório, ou se

deve solicitar MRPA. Ao longo da aula, vamos destrinchar todos esses conceitos para que essa questão se torne simples para vocês.

Diagnóstico da Hipertensão Arterial

Primeiramente, vamos entender como diagnosticar hipertensão arterial. Hoje em dia, trabalhamos com dois conceitos fundamentais: **pressão arterial no consultório** e **pressão arterial fora do consultório**. Essas duas formas de medida têm critérios diagnósticos diferentes, então precisamos dominar ambas.

No consultório, como fazemos o diagnóstico? Precisamos encontrar uma **PAS maior ou igual a 140 mmHg e/ou PAD maior ou igual a 90 mmHg em duas consultas diferentes**. Percebam que no consultório são necessárias duas aferições em momentos distintos. Isso é importante porque uma medida isolada pode não representar a realidade do paciente.

Agora, falando sobre medidas fora do consultório, temos o **MAPA** (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial). Diferentemente do consultório, **só um MAPA já é suficiente para dar o diagnóstico**. Mas como interpretar o MAPA? Vocês precisam decorar esses valores porque eles caem constantemente nas provas:

- **Nas 24 horas:** PAS maior ou igual a 130 mmHg e/ou PAD maior ou igual a 80 mmHg
- **Na vigília:** PAS maior ou igual a 135 mmHg e/ou PAD maior ou igual a 85 mmHg
- **No sono:** PAS maior ou igual a 120 mmHg e/ou PAD maior ou igual a 70 mmHg

Comentário crítico: Prestem atenção especial nos valores do sono, que são menores porque é esperado que durante o período de descanso a pressão arterial fisiologicamente reduza. Se o paciente não apresenta essa queda noturna adequada, isso pode indicar um padrão de hipertensão mais grave ou presença de outras condições associadas, como apneia do sono.

Existe ainda a **MRPA** (Monitorização Residencial da Pressão Arterial), que é menos cobrada em provas, mas vale conhecer. O paciente realiza três medidas pela manhã e três medidas à noite durante cinco dias consecutivos, usando um aparelho calibrado e sabendo aferir corretamente. Fazemos a média de todos esses valores e, se a **PAS for maior ou igual a 130 mmHg** ou a **PAD maior ou igual a 80 mmHg**, está dado o diagnóstico.

Fenótipos da Hipertensão Arterial

Quando diagnosticamos um paciente com hipertensão arterial, existem alguns fenótipos específicos que precisamos reconhecer, e dois deles são extremamente cobrados em provas: **hipertensão do avental branco** e **hipertensão mascarada**.

A **hipertensão do avental branco** ocorre quando o paciente apresenta pressão arterial alterada no consultório, mas quando fazemos o MAPA ou MRPA, a pressão está completamente normal. Ou seja, só fica hipertenso quando está no ambiente médico, provavelmente por ansiedade ou estresse situacional. Esse é um diagnóstico importante porque evitamos tratar desnecessariamente um paciente que, na verdade, não tem hipertensão sustentada.

Já a **hipertensão mascarada** é o oposto: no consultório a pressão está normal, você examina o paciente e pensa "ótimo, está tudo bem", mas quando ele faz o MAPA ou MRPA, a pressão vem alterada. Essa é uma situação mais preocupante porque o paciente está hipertenso na maior parte do tempo, mas isso não é detectado nas consultas de rotina.

Se o paciente está **normal nos dois exames** (consultório e MAPA/MRPA), ele é classificado como **normotenso** – vida que segue, sem necessidade de tratamento anti-hipertensivo. Se está **alterado nos dois**, temos uma **hipertensão sustentada**, que é o cenário mais comum e que definitivamente necessita de tratamento.

Mas quando devemos suspeitar desses fenótipos específicos? Para a **hipertensão do avental branco**, pensamos nela em algumas situações:

- Paciente com **hipertensão estágio 1 no consultório** sem lesão de órgão-alvo ou lesão subclínica
- Paciente que iniciou tratamento com baixa dose de medicação e começou a apresentar **sintomas de hipotensão** – nesse caso, podemos estar tratando desnecessariamente alguém que na verdade tem hipertensão do avental branco

Para a **hipertensão mascarada**, que considero ainda mais importante para as provas, pensamos nela quando:

- Paciente com **PA limítrofe** (aquele pré-hipertenso que está quase entrando no território da hipertensão)
- Paciente **normotenso mas que já tem lesão de órgão-alvo** – por exemplo, já apresenta proteinúria ou alterações no eletrocardiograma. Esse é um conceito que as provas adoram: se o paciente tem pressão normal no consultório mas já tem sinais de dano em órgãos-alvo, desconfie de hipertensão mascarada
- Pacientes normotensos mas com **risco cardiovascular alto ou múltiplas comorbidades** – por exemplo, o paciente chega no consultório com pressão normal, mas é diabético, obeso, sedentário, tabagista. Você olha para esse conjunto de fatores e pensa: "Será mesmo que esse paciente é normotenso?" Nesse perfil, vale a pena solicitar um MAPA
- Quando há **discrepância entre o relato do paciente e a PA aferida em consultório** – o paciente conta que tem medido em casa e os valores estão diferentes do que você encontra

Mnemônico útil: Para lembrar os fenótipos, pense em "MÁSCARAS ESCONDEM, AVENTAIS APARECEM" – na hipertensão mascarada, a HAS fica escondida no consultório; na do avental branco, a HAS só aparece no consultório.

Classificação da Hipertensão Arterial

Aqui temos uma **grande novidade da diretriz de 2025** que certamente vai cair nas provas. A classificação ficou mais simples e algumas categorias mudaram. Vamos aos valores que vocês precisam decorar:

- **Pressão normal:** PAS menor que 120 mmHg e PAD menor que 80 mmHg
- **Pré-hipertensão:** PAS de 120 a 139 mmHg e/ou PAD de 80 a 89 mmHg
- **Hipertensão estágio 1:** PAS de 140 a 159 mmHg e/ou PAD de 90 a 99 mmHg
- **Hipertensão estágio 2:** PAS de 160 a 179 mmHg e/ou PAD de 100 a 109 mmHg
- **Hipertensão estágio 3:** PAS maior ou igual a 180 mmHg e/ou PAD maior ou igual a 110 mmHg

Atenção para a mudança: Os estágios 1, 2 e 3 não mudaram em relação à diretriz anterior. O que mudou foi o conceito de pressão normal – antes existia uma categoria chamada "PA ótima" que não existe mais. E, principalmente, **agora PAS entre 120-139 mmHg e PAD entre 80-89 mmHg já é considerado pré-hipertensão**. Isso é extremamente importante porque esses pacientes já vão receber orientações e, em algumas situações específicas, até medicação.

Estratificação de Risco

Depois de diagnosticar e classificar o paciente, precisamos estratificá-lo quanto ao risco cardiovascular. Não vou pedir para vocês decorarem toda a tabela de estratificação, mas é fundamental conhecer os extremos, que são os mais cobrados.

Paciente estágio 3 já é automaticamente considerado de **muito alto risco ou alto risco**, independentemente de quais outros fatores de risco ele tenha. Da mesma forma, o **paciente estágio 2** praticamente sempre será alto risco – ele só seria classificado como risco moderado se não tivesse absolutamente nenhum fator de risco adicional, o que é extremamente raro na prática.

Para o **paciente estágio 1**, a estratificação vai depender dos fatores de risco: se tiver muitos fatores de risco, será considerado muito alto ou alto risco; se tiver poucos ou nenhum, será baixo risco. E para o **paciente pré-hipertenso**, se ele tiver muitos fatores de risco, isso se torna importante porque esse paciente já vai ter algumas condutas específicas traçadas.

Mas existe um atalho que simplifica muito as coisas e que vocês precisam gravar. Existem alguns **critérios que, de largada, já colocam o paciente automaticamente como alto risco**, independentemente do estágio da hipertensão ou de qualquer outro fator:

- **Doença cardiovascular manifesta**
- **Diabetes mellitus**
- **Doença renal crônica (DRC)**
- **Lesão de órgão-alvo (LOA)**
- **Hipercolesterolemia familiar**
- **Score PREVENT maior ou igual a 20%**

O score PREVENT é um escore que ganhou muita força nas últimas diretrizes. Ele avalia o risco cardiovascular do paciente nos próximos 10 anos. Se o resultado for maior ou igual a 20%, o paciente automaticamente é considerado de alto risco.

Comentário crítico: Na prática clínica, muitos pacientes vão se enquadrar nesses critérios de alto risco. Por exemplo, um paciente hipertenso estágio 1 que também é diabético já é automaticamente alto risco. Isso tem implicações diretas no tratamento, como veremos adiante.

Voltando à nossa questão da UNICAMP: temos um paciente com PA no consultório de 144 por 72 mmHg, o que caracterizaria hipertensão estágio 1. Porém, quando olhamos o MAPA dele, a pressão sistólica nas 24 horas foi de 132 mmHg, que está acima do valor de corte de 130 mmHg. Portanto, está dado o diagnóstico: **o paciente tem hipertensão arterial confirmada e deve ser iniciado tratamento**. A resposta correta é a alternativa B.

Tratamento da Hipertensão Arterial

Antes de começar a tratar, precisamos definir qual é a **meta de pressão arterial** que queremos atingir para aquele paciente específico. Afinal, você pode querer uma sistólica de 120 mmHg, 130 mmHg ou outro valor – isso precisa estar bem estabelecido antes de iniciar qualquer medicação.

De maneira geral, a meta é **menor ou igual a 130 por 80 mmHg** para a grande maioria dos pacientes. Quando pensamos em metas diferentes?

- **Idosos frágeis, muito idosos (geralmente maiores de 80 anos) ou pacientes com condições que comprometem a expectativa de vida:** nesses casos, a meta será o **valor máximo tolerado pelo paciente**. Por exemplo, se você tem um paciente muito idoso, acamado, com sistólica de 160 mmHg mas assintomático, obviamente não faz sentido trazer esse paciente para uma pressão de 130 mmHg porque não haverá benefício e você pode causar mais mal do que bem.
- **Pacientes que não toleram:** às vezes o paciente tem indicação de ficar com 130 por 80 mmHg, mas quando você começa a medicação ele já fica sintomático, com tonturas, mal-estar. Nesses casos, vamos tolerar o máximo que mantenha o paciente assintomático.

Quando iniciar tratamento medicamentoso?

Aqui vem uma pergunta fundamental: será que vamos começar medicamento para todo mundo que tem hipertensão? A resposta é **não**.

Existem situações em que começamos apenas com **tratamento não medicamentoso** (modificação do estilo de vida). Isso acontece quando o paciente tem pressão de **130 a 139 mmHg na sistólica ou 80 a 89 mmHg na diastólica** – ou seja, o **paciente pré-hipertenso**. Esse paciente vai fazer **mudança de estilo de vida (MEV) durante 3 meses** antes de pensar em medicação.

Se após esses 3 meses de MEV o paciente não melhorou ou se tornou hipertenso, ou se ele se mantém pré-hipertenso mas é de **alto risco**, aí sim podemos iniciar tratamento medicamentoso para ele.

Monoterapia ou dupla terapia?

Outra questão crucial: quando vou começar o tratamento, devo iniciar com uma droga só (monoterapia) ou com duas drogas diferentes (dupla terapia)? A regra é clara: **dupla terapia para todos, exceto** em algumas situações específicas:

- **Indivíduos frágeis**
- **Maiores de 80 anos**
- **Pacientes pré-hipertensos de alto risco**
- **Pacientes estágio 1 de baixo risco**

Por isso, quando estudamos estratificação de risco, pedi para vocês guardarem bem o conceito de **pré-hipertenso de alto risco** e **estágio 1 de baixo risco**, porque esses dois perfis vão começar com monoterapia. Todo o restante começa com dupla terapia.

Tratamento Não Medicamentoso

Quais são as medidas não farmacológicas que podemos orientar? Várias ações têm impacto comprovado na redução da pressão arterial:

- **Perda ponderal:** cada quilo de peso que o paciente perde reduz aproximadamente **1 mmHg na pressão arterial**. É uma medida extremamente efetiva.
- **Atividade física:** tanto aeróbia quanto resistida, com meta de **150 minutos por semana**
- **Moderar consumo de álcool:** até 2 drinks para homens e 1 drink para mulheres

- **Dieta DASH:** rica em frutas, vegetais, grãos integrais e com baixo teor de gordura
- **Restrição de sódio:** limitar a **2g de sódio por dia**, que equivale a aproximadamente 5g de sal de cozinha
- **Aumentar ingestão de potássio:** 3,5 a 5 g por dia
- **Cessar tabagismo**
- **Reduzir cafeína:** menos de 200 mg por dia
- **Manter vitamina D no alvo**
- **Regular o estresse**

Essas medidas devem ser orientadas para **TODOS** os pacientes hipertensos, independentemente do uso de medicação. Na verdade, muitas vezes a resposta às medidas não medicamentosas é tão boa que conseguimos reduzir ou até suspender medicamentos em alguns casos.

Classes Medicamentosas de Primeira Linha

Quais são as classes que consideramos de primeira linha para hipertensão? Tradicionalmente, tínhamos quatro classes bem estabelecidas:

- **IECA** (Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina)
- **BRA** (Bloqueadores do Receptor de Angiotensina)
- **Diuréticos tiazídicos**
- **Bloqueadores de canal de cálcio (BCC)**

Mas agora prestem muita atenção, porque isso é uma **grande novidade da diretriz de 2025** e tenho certeza absoluta de que vai cair nas provas: o **beta-bloqueador voltou a ser considerado tratamento de primeira linha** em algumas situações específicas.

Quais são essas situações em que posso usar beta-bloqueador como primeira linha?

- **Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)**

- Síndrome coronariana aguda (SCA)
- Pós-infarto agudo do miocárdio (IAM)
- Angina
- Fibrilação atrial (FA)
- Arritmias
- Tremor essencial
- Prolapso de válvula mitral
- Enxaqueca
- Ansiedade
- Hipertensão portal
- Síndromes hipercinéticas (como tireotoxicose)
- Apneia obstrutiva do sono

Diuréticos Tiazídicos

Vamos falar um pouco sobre cada classe especificamente. Começando pelos **tiazídicos**, como eles funcionam? O mecanismo tem dois componentes:

1. **Primeiro**: inibem a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal e aumentam a reabsorção de cálcio
2. **Segundo** (e esse é o efeito anti-hipertensivo principal): reduzem a resistência vascular periférica

Os representantes principais são **hidroclorotiazida**, **indapamida** e **clortalidona**.

Vantagens: têm efeitos benéficos na osteoporose e na nefrolitíase, justamente porque aumentam a reabsorção de cálcio e diminuem a calciúria (excreção de cálcio na urina).

Agora vem uma parte que as provas adoram cobrar: os **efeitos colaterais dos tiazídicos**. Para facilitar, vou ensinar vocês a organizarem em "quatro hipos" e "quatro hipers":

Os "hipos":

- Hipocalemia
- Hiponatremia
- Hipomagnesemia
- Hipovolemia

Os "hipers":

- Hiperuricemia
- Hiperglicemia
- Hiperlipidemia
- Hipercalcemia

E qual é a **contraindicação** mais cobrada dos tiazídicos? **Gota**. Isso é amplamente cobrado em provas.

Outras contraindicações incluem **hiperparatireoidismo primário** e **clearance de creatinina menor que 30 mL/min** (embora essa última seja uma contraindicação questionável atualmente).

Precauções: em pacientes diabéticos, os tiazídicos podem piorar o controle glicêmico. Não é contraindicação absoluta, mas é esperado que a glicemia desse paciente possa aumentar. Além disso, a **associação de tiazídico com beta-bloqueador pode piorar tanto a dislipidemia quanto a glicemia**.

Inibidores da ECA (IECA)

O mecanismo dos IECA é fundamental entender: eles **dilatam a arteríola eferente do glomérulo**. Isso é um conceito cobrado em prova. Com isso, diminuem a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal, levando a uma piora transitória da função renal.

Os representantes principais são **enalapril, captopril e lisinopril**.

Vantagens: reduzem mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e na doença arterial coronariana. Além disso, têm um importante **efeito nefroprotetor** para pacientes com doença renal crônica.

Efeitos colaterais: os três principais que vocês precisam saber são **tosse seca** (causada pelo acúmulo de bradicinina), **angioedema** e **hipercalcemia**.

Contra Indicações mais importantes:

- **Gestação:** extremamente cobrado em prova. Se uma paciente que vinha usando IECA engravida, você DEVE suspender imediatamente e trocar por outras opções.
- **Nunca associar IECA com BRA** (são classes que atuam no mesmo sistema)
- **Estenose de artéria renal bilateral ou unilateral em rim único**
- **Creatinina maior que 3 mg/dL**
- **Hipercalcemia**

Um critério importante: se houver piora da função renal **maior que 30%** após iniciar IECA, você deve suspender a medicação.

Bloqueadores do Receptor de Angiotensina (BRA)

Os BRAs atuam bloqueando o receptor AT1 da angiotensina II. Os representantes principais são **losartana, valsartana, olmesartana e candesartana**.

Vantagens: assim como os IECA, reduzem a mortalidade na doença arterial coronariana e na ICFe, e têm efeito nefroprotetor. Não devem ser associados com IECA.

Um detalhe interessante: **somente a losartana** tem efeito uricosúrico. Algumas provas gostam de cobrar esse conceito. Por exemplo, naquele paciente com gota e hipertensão, uma estratégia seria usar losartana porque, além de tratar a HAS, você ganha um efeito adicional no tratamento da gota pela redução do ácido úrico.

Efeitos colaterais: **angioedema** e **hipercalcemia** (mas NÃO causam tosse seca como os IECA, justamente porque não há acúmulo de bradicinina).

Contraindicações são muito parecidas com as dos IECA:

- Estenose de artéria renal (bilateral ou unilateral em rim único)
- Creatinina maior que 3 mg/dL
- Gravidez
- Uso conjunto com IECA
- Piora da função renal maior que 30%

Bloqueadores de Canal de Cálcio (BCC)

O representante mais usado na prática é o **anlodipino**. O mecanismo é reduzir o cálcio intracelular, o que reduz a contração e a resistência vascular periférica.

Dentro dos bloqueadores de canal de cálcio, temos duas subclasses:

Di-hidropiridínicos (DHPs): são os que usamos principalmente para hipertensão, pois fazem vasodilatação. Exemplos: **anlodipino, nifedipino, levamlodipino**.

Não di-hidropiridínicos: usamos mais para controle de frequência cardíaca em algumas situações, pois reduzem inotropismo e cronotropismo. Exemplos: **verapamil e diltiazem**.

Vantagens dos BCC:

- Reduzem o risco de **acidente vascular cerebral**
- São **antianginosos** (benefício extra para paciente com angina e HAS)
- São **seguros na doença renal crônica**
- São a **primeira escolha em afrodescendentes**

Efeitos colaterais:

- **DHPs:** edema maleolar, dermatite ocre, rubor facial

- **Não DHPs:** bradiarritmias, constipação intestinal, podem descompensar ICFe

Contraindicações (para os não di-hidropiridínicos):

- ICFe
- BAV de 2º ou 3º grau

Beta-bloqueadores

Como já mencionamos, voltaram como primeira linha em situações específicas. O mecanismo é fazer bloqueio dos receptores beta-1 e beta-2.

Representantes principais: **atenolol, propranolol, carvedilol, metoprolol, bisoprolol.**

Efeitos colaterais:

- **Broncoespasmo**
- **Bradicardia e bloqueio AV**
- **Hipercalemia**
- **Hiperglicemia**
- **Dislipidemia**
- **Insônia e pesadelos**
- **Disfunção sexual**

Contraindicações: BAV de 2º e 3º grau é contraindicação para todos.

Dentro dos beta-bloqueadores, temos os **cardiosseletivos** (principalmente carvedilol e metoprolol) e os **não seletivos** (principalmente atenolol e propranolol).

Os **não seletivos** têm contraindicações adicionais:

- **Intoxicação por cocaína**
- **Angina vasoespástica (Prinzmetal)**
- **Feocromocitoma**
- **Doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) descompensada**

Precaução: a associação de beta-bloqueador com tiazídico pode piorar hiperglicemia e dislipidemia.

Hipertensão Arterial Resistente

E se não conseguimos controlar a pressão do paciente mesmo usando três classes de primeira linha, incluindo um tiazídico? Esse paciente recebe o nome de **hipertenso resistente**.

O que fazer nesses casos?

Primeiro passo: sempre **checar a adesão**. A grande maioria dos casos de "hipertensão resistente" é na verdade problema de adesão ao tratamento.

Segundo passo (novidade da diretriz): se o tiazídico usado for hidroclorotiazida, podemos **trocar por indapamida ou clortalidona**. Embora não haja evidência muito robusta, isso está na nova diretriz.

Terceiro passo: se fizemos essa troca e não deu certo, a **quarta droga na hipertensão arterial resistente é a espironolactona**. Vocês precisam decorar isso porque cai muito em provas. Paciente usando três classes incluindo tiazídico e não controla: qual a quarta droga? **Espironolactona**.

Quarto passo: nesse perfil de paciente com HAS resistente, devemos começar a investigar **causas secundárias de hipertensão**.

Espironolactona e Antagonistas da Aldosterona

A espironolactona pertence à classe dos **antagonistas da aldosterona**. O mecanismo é inibir a reabsorção de sódio no túbulo coletor. Outros representantes: **eplerenona, amilorida e triantereno**.

Vantagens:

- **Contrabalanceiam a hipocalemia** de outros diuréticos (enquanto tiazídico abaixa potássio, espironolactona aumenta)
- **Primeira escolha no hiperaldosteronismo primário**
- Reduzem mortalidade na ICFe

Efeitos colaterais:

- **Ginecomastia**
- **Disfunção sexual**
- **Irregularidade menstrual**
- **Hipercalemia** (mais cobrado em provas)

Contraindicações: hipercalemia e gestação.

Precauções: associação com IECA ou BRA não é contraindicada, mas ambas as medicações podem causar hipercalemia, então ao juntá-las o potássio pode subir significativamente e precisamos monitorar de perto.

Hipertensão Arterial Refratária

Se associamos espironolactona e o paciente continua sem controlar a pressão, ele ganha um novo nome: **HAS refratária**. Nesse caso, a quinta classe não tem uma regra específica. Podemos usar várias opções:

- **Agonistas alfa-2:** clonidina, metildopa
- **Bloqueadores alfa-1:** prazosina, doxazosina
- **Vasodilatadores diretos:** hidralazina, minoxidil
- **Diuréticos de alça:** furosemida

A escolha do fármaco fica a critério do médico que estiver acompanhando o paciente.

Hipertensão Secundária

Quando devemos suspeitar que a hipertensão não é primária (essencial), mas sim secundária a alguma causa específica? Existem alguns cenários:

- **Início precoce** (menor que 30 anos) ou **tardio** (maior que 55 anos)
- Paciente que já começa com **hipertensão estágio 3 de forma súbita**
- **Hipertenso resistente** (como já conversamos)
- Paciente que estava **bem controlado há anos e de repente descompensa**

Alguns **gatilhos específicos** nas provas para pensar em HAS secundária:

- **Hipocalemia** sem uso de diurético
- **Crises adrenérgicas**
- **Sinais de endocrinopatia** (face de lua cheia, estrias violáceas, giba, etc.)
- **Roncos e sonolência** (apneia do sono)
- **Assimetria de pulsos**
- **Sopro abdominal**
- **Uso de drogas que aumentam PA** (anticoncepcionais, corticoides, AINEs, etc.)

Vou dar para vocês um conjunto de informações extremamente útil: **causas de HAS secundária e qual exame solicitar para cada uma**. Isso mata boa parte das questões:

- **Apneia e hipopneia do sono**: roncos, sonolência diurna → **polissonografia**
- **Hipertensão renovascular**: sopro abdominal → **Doppler de artérias renais**
- **Hiperaldosteronismo primário**: hipocalemia sem causa aparente → **dosagem de aldosterona e renina**
- **Feocromocitoma**: cefaleia, palpitação, crise adrenérgica, tremor → **dosagem de metanefrinas e catecolaminas urinárias de 24 horas**
- **Coarctação de aorta**: pulsos assimétricos, diferença de PA entre membros → **angiotomografia de aorta**

- **Síndrome de Cushing:** face em lua cheia, estrias violáceas, equimoses → cortisol salivar à meia-noite, cortisol matinal após 1 mg de dexametasona, cortisol urinário de 24h
- **Hiper/hipotireoidismo:** sinais clínicos de disfunção tireoidiana → TSH e T4 livre
- **Acromegalia:** características acromegálicas → dosagem de IGF-1

Emergências Hipertensivas

Primeiro conceito importante: "**urgência hipertensiva**" não se usa mais. A nova diretriz enfatiza que esse termo caiu em desuso.

O que é **emergência hipertensiva**? É quando temos **PAS maior ou igual a 180 mmHg e/ou PAD maior ou igual a 120 mmHg, COM sintomas, COM lesão de órgão-alvo e risco de morte iminente.**

Principais emergências hipertensivas:

- **AVC** (isquêmico ou hemorrágico)
- **Encefalopatia hipertensiva**
- **Hipertensão acelerada maligna**
- **Síndrome coronariana aguda**
- **Dissecção aguda de aorta**
- **Crise de feocromocitoma**
- **Eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave**

Tratamento: anti-hipertensivo **endovenoso**. As duas opções mais usadas na prática são:

- **Nitroglicerina** (Tridil)
- **Nitroprussiato de sódio** (Nipride)

Metas de Pressão Arterial nas Emergências Hipertensivas

Aqui não é meta como no ambulatório – são metas específicas para a situação aguda:

De maneira geral: reduzir em torno de **25% na primeira hora**.

Situações específicas:

AVC isquêmico:

- Se for trombolizar: antes de iniciar trombólise, PA deve estar **menor que 185/110 mmHg**; após iniciar trombólise, manter **menor que 180/105 mmHg** nas primeiras 24 horas
- Se não for trombolizar: alvo é **menor que 220/120 mmHg**

AVC hemorrágico, SCA, crise de feocromocitoma, eclâmpsia: trazer PAS para em torno de **140 mmHg na primeira hora**

Hemorragia subaracnoide (HSA): meta é **160 mmHg de sistólica**

Dissecção aguda de aorta: aqui a meta é mais agressiva. Primeiro, você deve reduzir a **frequência cardíaca para cerca de 60 bpm** (geralmente com beta-bloqueador), e só depois trazer a PAS para cerca de **120 mmHg**

Resumo dos Gatilhos Principais

Vou consolidar os pontos-chave que vocês não podem esquecer:

1. **A classificação mudou na diretriz 2025:** PAS 120-139 e/ou PAD 80-89 já é **pré-hipertensão**
2. **Critérios de alto risco independente** (decorar): DCV, DM, DRC, LOA, hipercolesterolemia familiar, PREVENT $\geq 20\%$
3. **Beta-bloqueador voltou como primeira linha** em situações específicas: ICFeR, SCA, pós-IAM, angina, FA, arritmias, tremor essencial, prolapso de válvula

mitral, enxaqueca, ansiedade, hipertensão portal, síndromes hiperkinéticas, apneia do sono

4. **HAS resistente:** quarta droga é sempre **espironolactona**
5. **Valores do MAPA** (decorar): 24h $\geq 130/80$; vigília $\geq 135/85$; sono $\geq 120/70$
6. **Hipertensão do avental branco:** pensar quando estágio 1 sem LOA, PA elevada sem LOA, ou sintomas de hipotensão após iniciar tratamento em baixa dose
7. **Hipertensão mascarada:** pensar quando normotenso, mas com LOA, ou normotenso com múltiplas comorbidades/alto risco CV
8. **Tiazídico:** contraindicado na gota (hiperuricemia)
9. **IECA e BRA:** contraindicados na gestação, estenose de artéria renal bilateral, nunca associar os dois
10. **Monoterapia:** apenas para frágeis, > 80 anos, pré-hipertenso de alto risco, estágio 1 de baixo risco

Espero que esse material tenha ficado claro e didático para vocês. Hipertensão arterial é um tema extenso mas extremamente recorrente nas provas, então vale muito a pena dominar esses conceitos. Continuem estudando, revisem os pontos principais e, principalmente, façam muitas questões para fixar. Sucesso nas provas!